

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala para Evaluar el Riesgo Suicida (ERS)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	ERS
Nombre completo	Escala para Evaluar el Riesgo Suicida (ERS)
Versión / edición	Versión original colombiana de 20 ítems (no hay ediciones alternativas verificadas en esta fuente).
Idioma	Español (Colombia).
Autores (original)	Bahamón Muñetón, M. J., & Alarcón-Vásquez, Y. (2018). Desarrollada directamente en español; no es una adaptación de un instrumento en otro idioma.
Año (original / adaptación)	2018 (no aplica adaptación; instrumento desarrollado originalmente en Colombia).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Riesgo suicida; ideación suicida; desesperanza; aislamiento social; apoyo familiar; tamizaje.
Pregunta clínica que responde	¿Existe un nivel de riesgo suicida clínicamente relevante (ideación, planeación, antecedentes, factores psicosociales) que requiera intervención inmediata o seguimiento?
Población	Adolescentes (desde 12 años) y adultos; validada en adolescentes colombianos hispanohablantes.
Contexto de aplicación	Tamizaje en colegios y universidades, servicios de urgencias médicas y atención psicológica primaria.
Informante	Autoinforme; también aplicable en entrevista de cribado.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o entrevista breve; individual.
Número de ítems	20 ítems (verificado por conteo directo en el formulario administrable).
Periodo temporal de referencia	Últimos seis meses (confirmado en el encabezado del propio formulario).
Formato de respuesta	Escala Likert de 6 puntos: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = parcialmente en desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 = de acuerdo, 6 = totalmente de acuerdo (verificado en el formulario).
Tiempo estimado de aplicación	Aproximadamente 3 a 5 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).

Regla de puntuación	Suma directa de los 20 ítems. Puntuación total entre 20 y 120; no se identificaron ítems invertidos (declarado en la ficha técnica fuente).
Ítems invertidos	Ninguno, según la ficha técnica fuente.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	20-120.
Puntos de corte	La ficha técnica fuente reporta clasificación por percentiles: riesgo bajo/sin riesgo (percentil <50), riesgo moderado (percentil 50-85, requiere apoyo terapéutico preventivo), riesgo alto (percentil >85, requiere activación inmediata de protocolo de emergencia en salud mental). No se localizó en esta sesión la tabla de percentiles poblacional original ni se verificó contra el artículo primario — usar con cautela hasta confirmar contra la fuente original.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario administrable de 20 ítems, copiado desde la carpeta suelta Downloads/Instrumentos/Eje I/ERS/ERS_Scale.pdf de la raíz del proyecto; el mismo archivo había quedado erróneamente adjunto como protocolo de IES-R, error corregido el 2026-09-10). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde la carpeta suelta Eje I/ERS de la raíz del proyecto. Ficha construida a partir de la ficha técnica clínica ya elaborada en esa carpeta (ERS_Ficha.pdf, 3 páginas, formato de 14 secciones) y verificación directa del formulario administrable (ERS_Scale.pdf, coincide en estructura e ítems declarados). No se verificó independientemente el artículo original (Universitas Psychologica, 2018) contra fuente primaria en esta sesión — pendiente de verificación de psicometría y baremos. Requiere revisión humana antes de uso clínico.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: riesgo suicida, integrando cuatro dimensiones declaradas: depresión y desesperanza (ítems 1-6), ideación/planeación/autolesión (ítems 7-12), aislamiento y soporte social (ítems 13-16), y falta de apoyo familiar (ítems 17-20).

Finalidad: detectar y clasificar el nivel de riesgo suicida en adolescentes y adultos hispanohablantes, integrando factores cognitivo-conductuales y psicosociales.

Usos apropiados

Tamizaje rápido de riesgo suicida en contextos educativos, de urgencias y de atención primaria en salud mental.

Primera línea de detección antes de una evaluación clínica estructurada del riesgo suicida.

Usos NO apropiados

Sustituir una evaluación clínica de riesgo suicida detallada, especialmente ante puntuaciones en rango alto, ítems 7-12 positivos, o antecedentes de intento.

Diagnóstico autónomo o decisión de alta/derivación sin juicio clínico profesional.

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollada originalmente en español (Colombia) en población adolescente; la ficha técnica fuente reporta alfa de Cronbach global de 0.90 y coeficientes superiores a 0.75 en cada una de las cuatro dimensiones, con un modelo de cuatro factores confirmado por análisis factorial confirmatorio. Estos datos no se verificaron de forma independiente contra el artículo original en esta sesión — pendiente de verificación directa.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Depende del reporte sincero del evaluado; existe riesgo de ocultamiento por temor a hospitalización o consecuencias (limitación declarada en la ficha técnica fuente).

Ante ítems 7-12 positivos (ideación, planeación, intentos previos, autolesión) o puntuación en rango alto, activar protocolo clínico de evaluación de riesgo suicida y de seguridad de forma inmediata, independientemente del puntaje total.

No sustituye una entrevista clínica estructurada de riesgo suicida ni el juicio profesional.

Instrumento de contenido sensible: administrar con consentimiento informado y en condiciones que permitan seguimiento clínico inmediato si es necesario.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicado en Universitas Psychologica (revista académica). No se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de cualquier distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Bahamón Muñetón, M. J., & Alarcón-Vásquez, Y. (2018). Diseño y validación de una escala para evaluar el riesgo suicida (ERS) en adolescentes colombianos. *Universitas Psychologica*, 17(4), 1-15.

Bahamón Muñetón, M. J., et al. (2019). Estilos de afrontamiento como predictores del riesgo suicida en estudiantes adolescentes. *Revista Psicología desde el Caribe*, 36(1), 3-21.